

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 2223 286 5387 | 125

MARIA EVA DOS SANTOS

IDADE: 72	PESO: 81	ALTURA: 159	PROFISSÃO: Comerciante - Roupa
SINTOMAS: Dor de cabeça / mmf edema / fadiga mmf / dificuldade pl perder peso.			
QUEIXAS: Sono incômodo (acorda muitas)			
MEDICAMENTOS: Brasart / Xitorito / Adera / Glifage / Domaren (50mg)			
HAS / glicemia (no limite) / Colesterol / simvastatina			
MÉDICO: Dr. Keffel - Dr. Maria das graças / Semaglutida			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N de for.			
EXERCÍCIO FÍSICO: 2x pilates / 2 bicicleta em casa			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (20h)			
HORA QUE DORME: 21:30 HORA QUE ACORDA: 5h			
COCHILO () S ☒ N		DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE	
TEM FILHOS: () S ☒ N		DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N	
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N			
FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO/NOITE: 3x 5x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI:	IAH: 47	SPO2: 76%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Renal Crônica (4a) SpO2 = 87% Dor no corpo			
CIRURGIAS: (N) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA		(N) NEUROLÓGICA () OUTROS: IAH = 82%	
POLISSONOGRAFIA COM CPAP: ☒ S () N		SPO2 CI/CPAP: 82% PRESSÃO NO EXAME: 14	
19/11 - Avaliação			
27/11 P = 5-10 cmH2O * Relata que melhorou a dor de cabeça.			
24 IAH = 5.2 elev 1x ao banheiro / dia.			
M. de uso: 9hr. fixo a P em 10cmH2O			
* máx Dream Ween			
12/12/24 P = 10cmH2O			
IAH = 3.5 e/h Bem adaptada			
m de uso: 7h21'			
fuga: 2,9 l/m			
26/12/24 * comprou CPAP básico * P: 10cmH2O rampa: 5,0cmH2O			
Umidif. 5.			
19/05/25 P = 10cmH2O Relata escape de ar.			
M. de uso: 7h46'			
Fuga = 25.2			

fuga.

29/03/25

P=10auH₂O

IAH=2,2e/h

mdc ure: 6h46'

fuga: 19l/m

Bem adaptado

Natasha

05/03/25

P=10auH₂O

IAH=2.8e/h

mdc ure: 7h7'

fuga: 24l/m

Coloco protetor de
tácida na max.

Peti apresentando leve edema
facial, maxila ajustada
Relata Prisão Alta

Natasha

Nome: MARIA EVA DOS SANTOS

Data de Nascimento: 14-7-1950

IMC: 34,02

Sexo: Feminino

Data do exame: 08-08-2024

Peso: 86 kg

Altura: 1,59 m

Médico: DR. KEFFEL ANTONIO

FERNANDES PEREIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 08-08-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 568,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 44,5 e 64,5 minutos. O tempo total de sono foi de 465,0 min, eficiência de 81,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,0%; estágio N2: 60,9%; estágio N3: 12,8%; sono REM: 24,3%. O índice de despertares foi de 25,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 46,8/hora, sendo 20 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 322 hipopnéias. A SpO2 média foi de 87% e a mínima de 76%, permanecendo 79,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 77 bpm e NREM de 53 - 80 bpm.

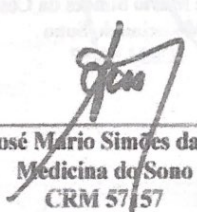
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (1), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 46,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=76%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (5,2/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: MARIA EVA DOS SANTOS
Data de Nascimento: 14-7-1950
IMC: 33,62
Sexo: Feminino
Data do exame: 09-09-2024

Peso: 85 kg
Altura: 1,59 m
Médico: DR. KEFFEL ANTONIO
FERNANDES PEREIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 09-09-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 479,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 27,0 e 171,5 minutos. O tempo total de sono foi de 330,0 min, eficiência de 68,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,8%; estágio N2: 50,3%; estágio N3: 23,0%; sono REM: 22,9%. O índice de despertares foi de 7,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 14,5/hora, sendo 15 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 65 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e a mínima de 82%, permanecendo 35,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 74 bpm e NREM de 54 - 67 bpm.

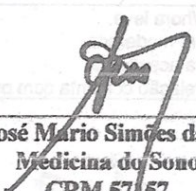
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (0), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 14,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157